PROJETO DE INTERVENÇÃO · UBS NACIONAL · CONTAGEM

DengueCare

Atendimento da dengue na Atenção Primária: do acolhimento à conduta, segundo o Ministério da Saúde (6ª ed., 2024)

Residência em Medicina de Família e Comunidade · PUC Minas · 2026 · Preceptor: Patrik Ferreira de Carvalho Pinto
Patricia G. de Marco · Guilherme O. Rodrigues · Walterez G. A. Barbosa · Marcus V. Tolentino · Pedro A. Rüger

POR QUE ESTE PROJETO

A maioria dos óbitos por dengue é evitável, com medidas simples feitas a tempo

Reconhecer

os sinais de alarme e de choque cedo, sobretudo quando a febre baixa

Classificar

cada paciente nos grupos A, B, C ou D e reclassificar a cada retorno

Hidratar

com o volume certo pelo peso, começando ainda na UBS

Fonte: Ministério da Saúde. Dengue: diagnóstico e manejo clínico – adulto e criança, 6ª ed., 2024

O ESSENCIAL DA DOENÇA

Três fases: o perigo começa quando a febre vai embora

2 a 7 dias

Febril

Febre alta súbita, cefaleia, mialgia, dor retro-orbital, exantema

3º ao 7º dia

Crítica

Começa na queda da febre: extravasamento de plasma, sinais de alarme, choque (mais no 4º ou 5º dia)

Depois

Recuperação

Reabsorção do líquido; atenção à hiper-hidratação

Não há antiviral: o tratamento é classificar e hidratar

CASO SUSPEITO

Febre de 2 a 7 dias + 2 ou mais manifestações

Em quem mora ou esteve, nos últimos 14 dias, em área com transmissão. Toda criança com febre aguda sem foco aparente também é caso suspeito.

Notificar sempre, na primeira unidade que atender. Exame específico não muda a conduta.

Manifestações

- Náuseas · vômitos
- Exantema
- Mialgias · artralgias
- Cefaleia · dor retro-orbital
- Petéquias · prova do laço positiva
- Leucopenia

Exames: NS1 ou RT-PCR até o 5º dia; IgM a partir do 6º

Sinais de alarme e sinais de gravidade

Alarme → Grupo C

- Dor abdominal intensa e contínua
- Vômitos persistentes
- Acúmulo de líquidos (ascite, derrames)
- Hipotensão postural ou lipotimia
- Fígado > 2 cm do rebordo costal
- Sangramento de mucosa
- Letargia ou irritabilidade
- Aumento progressivo do hematócrito

Gravidade → Grupo D

- Choque: taquicardia, extremidades frias, pulso fraco, enchimento capilar > 2 s
- PA convergente (diferencial < 20 mmHg), hipotensão, oligúria
- Desconforto respiratório
- Sangramento grave
- Lesão grave de órgão: AST/ALT > 1.000, consciência alterada, miocardite

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO · MS 2024

Quatro grupos, quatro lugares de cuidado

A • Azul

Sem alarme, sem sangramento, sem condição especial

Casa, com a UBS

B • Verde

Sangramento de pele, prova do laço + ou condição especial

Observação na UBS

C • Amarelo

Sinais de alarme presentes

Internação

D • Vermelho

Choque ou sinais de gravidade

UTI

ALGORITMO NA UBS · PASSOS 1 E 2

Acolher e avaliar antes de classificar

1 • Acolhimento

- Classificar o risco pela cor
- Priorizar alarme e choque
- Soro oral (SRO) já na sala de espera
- Notificar o caso suspeito

2 • Perguntar

- Dia de doença; a febre baixou?
- Dor abdominal, vômitos, tontura
- Sangramentos, diurese, ingesta
- Comorbidades, gestação, medicações

2 • Examinar

- **Peso**
- **PA deitado e em pé**
- FC, FR, perfusão
- Abdome, tórax, pele
- Prova do laço

ALGORITMO NA UBS · PASSO 3

Três perguntas, sempre nesta ordem

1. Há choque ou sinal de gravidade?	Sim →	**Grupo D · emergência**
2. Se não: há sinal de alarme?	Sim →	**Grupo C · urgência**
3. Se não: sangramento de pele, prova do laço + ou condição especial?	Sim →	**Grupo B · observação**
Nenhuma das três	→	**Grupo A · em casa**

O que fazer na UBS em cada grupo

Grupo	Na UBS, já	Para onde	Seguimento
D vermelho	SF 0,9% 20 mL/kg em até 20 min (até 3×) · O_2 no choque · reavaliar a cada 15 a 30 min	SAMU 192 → hospital com UTI	Manter soro no transporte · relatório com volumes
C amarelo	SF 0,9% 10 mL/kg na 1ª hora, mesmo sem exames · reavaliar em 1 h	Internação (UPA ou hospital), mín. 48 h	Manter soro na transferência
B verde	Observação com soro oral · hemograma em até 2 a 4 h	UPA se a UBS não tem o resultado no prazo	Ht alto ou alarme → C · normal → casa e reavaliação diária
A azul	Soro oral pelo peso · paracetamol ou dipirona	Casa	Retorno no dia em que a febre baixar (ou 5º dia) · visita do ACS

Hidratação oral e medicamentos

Volume por dia (A e B)

Adulto: 60 mL/kg

Criança: até 10 kg 130 · 10 a 20 kg 100 · acima de 20 kg 80 mL/kg

1/3 com SRO · 1/3 do volume nas primeiras 4 a 6 h · até 24 a 48 h após a febre

Usar

Paracetamol e/ou dipirona · criança 10 mg/kg/dose até de 6/6 h · adulto: paracetamol até 4 g/dia

Não usar

AINEs, AAS como analgésico e corticoides

Exemplo: adulto de 70 kg = 4,2 L/dia, sendo 1,4 L nas primeiras 4 a 6 h · somar o paracetamol dos antigripais

ALGORITMO NA UBS · PASSO 4 · ORIENTAR O PACIENTE

“Volte imediatamente se aparecer...”

- Dor forte na barriga que não passa
- Vômitos repetidos, não consegue beber
- Tontura ou desmaio ao levantar
- Sangramento de nariz, gengiva, vômito ou fezes escuras
- Muita sonolência ou irritação (criança)
- Falta de ar · urina muito pouca

O maior risco é quando a febre vai embora: continue bebendo líquidos e venha à reavaliação

Quem faz o quê na UBS

Recepção e enfermagem

- Acolhimento e cor de risco
- Sinais vitais, PA em 2 posições, peso
- Prova do laço e SRO na espera
- Notificação e Cartão

Médico(a)

- Grupo A, B, C ou D
- Hidratação, prescrição e exames
- Ajuste das medicações de uso contínuo
- Encaminhamento e relatório

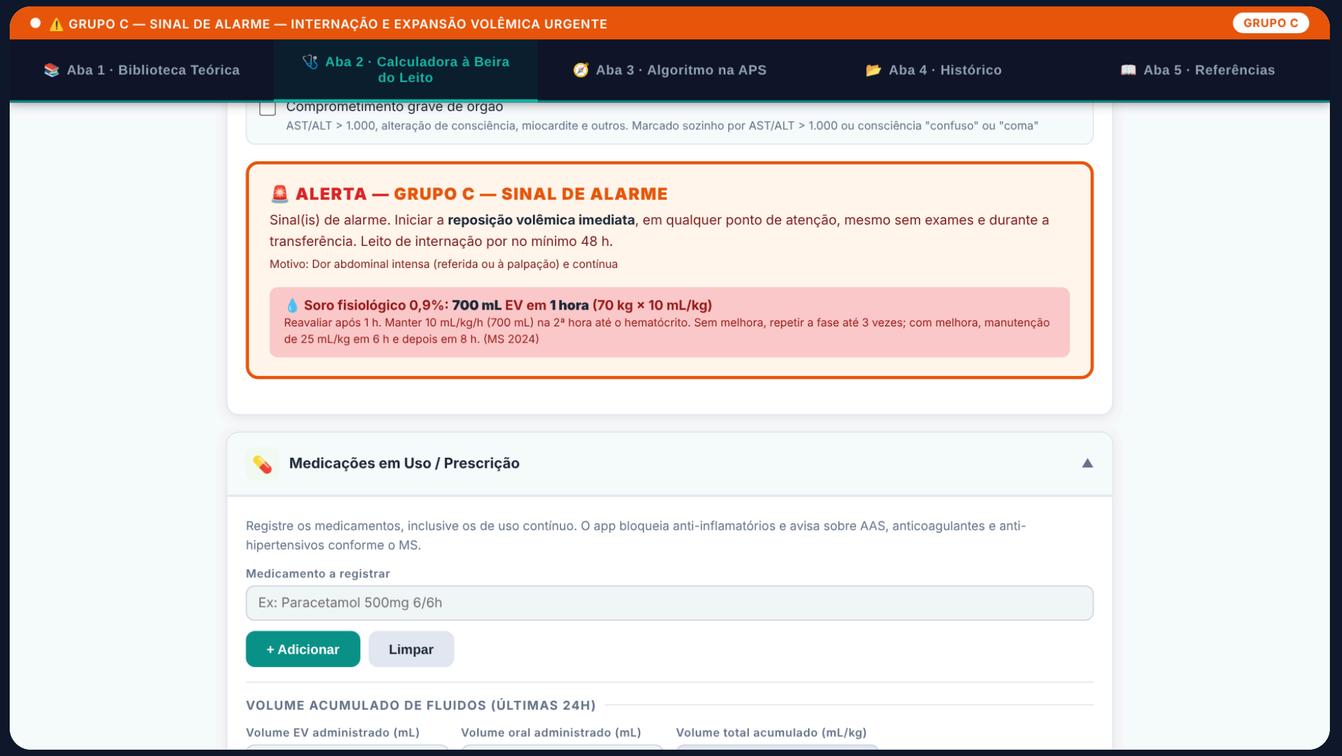
ACS

- Visita no período crítico
- Busca de faltosos ao retorno
- Orientação de sinais de alarme
- Eliminação de criadouros

O APLICATIVO

Calcula a conduta à beira do leito

- Triagem: caso suspeito
- Doses e volumes pelo peso
- Grupo automático e alerta
- Algoritmo da UBS
- Histórico no próprio aparelho



COMO ACESSAR

Aponte a câmera do celular

pedrorugerr-droid.github.io/denguecare

Abre no navegador do celular ou do computador, sem instalar nada.
Também existe a versão em arquivo único, que funciona sem internet.

Ferramenta de apoio: não substitui o julgamento clínico

Reclassifique
a cada reavaliação

Notifique
todo caso suspeito

Compartilhe
e envie sugestões

Obrigado! · DengueCare · UBS Nacional, Contagem · MFC PUC Minas 2026